Клинические рекомендации

Опухоли слюнных желёз у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C06.9** — Рта неуточненное **C07** — Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы **C08** — Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез **D10.3** — Других и неуточненных частей рта **D11** — Доброкачественное новообразование больших слюнных желез
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 27.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/75_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Дифференциальная диагностика 5

3.3 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование 6

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 УЗИ и тонкоигольная аспирационная биопсия 6

3.6 МРТ, КТ и другие исследования 7

3.7 Патолого-анатомическое заключение 7

4. Лечение 7

4.1 Хирургическое лечение 7

4.2 Лучевая терапия 8

4.3 Медицинская реабилитация 9

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

5.1 Профилактика и диспансерное наблюдение 9

5.2 Показания к госпитализации 10

6. Источник и актуальность **10**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- У детей и подростков 75–80% поражений слюнных желёз доброкачественные; самая частая опухоль — плеоморфная аденома. Раком (карциномой) слюнной железы называют злокачественную эпителиальную опухоль; у детей чаще всего встречается мукоэпидермоидная карцинома.
- **Обследование**
  1. УЗИ слюнных желёз и шейных лимфатических узлов с тонкоигольной аспирационной биопсией (ТАБ) и цитологией — всем;
  2. МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием — при подозрении на злокачественную опухоль;
  3. КТ лицевого черепа — при подозрении на поражение костей; КТ органов грудной клетки — при злокачественной опухоли.
- Лечение хирургическое: опухоль удаляют с выделением и сохранением лицевого нерва под нейрофизиологическим мониторингом, только в специализированном центре; энуклеация недопустима.
- Достаточный край резекции: при низком и промежуточном потенциале злокачественности — **2 мм и более**, при высоком (аденокистозный рак) — **5 мм и более**.
- **Контрольные обследования**
  1. первый год: **каждые 3 месяца**;
  2. до 5 лет: **не реже 1 раза в полгода**;
  3. далее: **не реже 1 раза в год**, при злокачественной опухоли — пожизненно.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак слюнной железы (карцинома) — злокачественная эпителиальная опухоль слюнной железы. К большим слюнным железам относят околоушную, подчелюстную и подъязычную, к малым — железы полости рта и ротоглотки.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возможные предрасполагающие факторы злокачественных опухолей

1. ионизирующая радиация;
2. ранее проведённая лучевая терапия;
3. хроническая вирусная инфекция.

Этиологические факторы доброкачественных образований неизвестны.

Плеоморфная аденома («смешанная опухоль») — самая частая доброкачественная опухоль: средний возраст 16 лет, девочки болеют в 1,43 раза чаще; околоушная железа поражается в 56%, подчелюстная — в 31%, малые железы — в 3,3% случаев. Злокачественные опухоли составляют 1–8% образований головы и шеи у детей: средний возраст 14 лет, околоушная железа поражается до 72%, малые железы — до 20%. Мукоэпидермоидная карцинома встречается до 53%, ацинарноклеточная — 29%, аденокистозная — 5%.

Инфантильная гемангиома и лимфатические мальформации клинически сходны с опухолями, но относятся к сосудистым аномалиям и рассматриваются в соответствующих клинических рекомендациях.

2.3 Классификация

Гистологическая классификация ВОЗ (5-е изд., 2022): 4 группы

1. ненеопластические эпителиальные поражения;
2. доброкачественные эпителиальные опухоли (плеоморфная аденома, опухоль Вартина и др.);
3. злокачественные эпителиальные опухоли (мукоэпидермоидная, аденокистозная, ацинарноклеточная, секреторная карцинома и др.);
4. мезенхимальные опухоли, специфичные для слюнных желёз (сиалолипома).

Гемангиома, лимфатические мальформации, лимфомы и саркомы из классификации исключены; классификация учитывает типичные перестройки генов для каждого типа опухоли.

Характерные молекулярные изменения

1. **мукоэпидермоидная карцинома** — перестройка CRTC1-MAML2 (40–90%)
2. **ацинарноклеточная карцинома** — перестройка/активация NR4A3 (86%)
3. **аденокистозная карцинома** — перестройка MYB (~80%)
4. **секреторная карцинома** — перестройка ETV6-NTRK3 (более 90%)
5. **рак протоков слюнных желёз** — амплификация HER2 (31%), мутация TP53 (56%)

Первичная опухоль (T), TNM 8-е изд.

1. **T1** — **2 см или менее** без распространения за пределы паренхимы
2. **T2** — **более 2 см, но не более 4 см** без распространения за пределы паренхимы
3. **T3** — **более 4 см** и (или) распространение за пределы паренхимы
4. **T4a** — распространение на кожу, нижнюю челюсть, слуховой проход и (или) лицевой нерв
5. **T4b** — распространение на крыловидные отростки, основание черепа или внутреннюю сонную артерию

Регионарные лимфатические узлы (N)

1. **N1** — один узел на стороне поражения **не более 3 см**
2. **N2** — один узел **более 3 см, но не более 6 см** (N2a), несколько узлов на стороне поражения (N2b), двустороннее или контралатеральное поражение (N2c) — до 6 см
3. **N3** — метастазы **более 6 см**

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Доброкачественные опухоли растут медленно: до установления диагноза нередко проходит около 5 лет. Основная жалоба — пальпируемое образование в околоушно-жевательной области, реже поражение лицевого нерва и боль. Тризм и образование боковой стенки глотки характерны для опухоли глубокой доли околоушной железы.

Злокачественные эпителиальные опухоли — медленно растущие образования околоушно-жевательной области или полости рта с крайне низкой потенцией к метастазированию; диагноз запаздывает в среднем на 8–12 месяцев.

Жалобы при злокачественной опухоли

1. безболезненное узловое образование плотноэластической консистенции, не спаянное с кожей, — 99%;
2. болезненность в области опухоли — 22%;
3. парез лицевого нерва — 7%: крайне неблагоприятный прогностический признак.

Опухоли глоточного отростка околоушной железы, несмотря на медленное течение, рано инфильтрируют слизистую оболочку глотки.

Прогноз

1. мукоэпидермоидная карцинома у детей в 87% случаев имеет низкий и промежуточный потенциал злокачественности;
2. пятилетняя общая выживаемость — 93%, безрецидивная — 82%;
3. рецидив возникает в среднем спустя год и месяц после операции.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Комплекс обследования при злокачественной опухоли

1. анамнез и жалобы;
2. осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфатических узлов;
3. УЗИ слюнных желёз, мягких тканей лица, лимфатических коллекторов шеи;
4. КТ с контрастированием при подозрении на поражение костей основания черепа или челюсти, при рецидиве;
5. МРТ с контрастированием при Т3–Т4, рецидиве, поражении глоточного отростка, подозрении на интракраниальное распространение;
6. ТАБ под контролем УЗИ с цитологическим исследованием опухоли и подозрительных узлов;
7. рентгенография или МСКТ органов грудной клетки;
8. сцинтиграфия костей скелета при первичной диагностике;
9. патолого-анатомическое исследование операционного материала с иммуногистохимией.

При доброкачественной опухоли

1. анамнез, осмотр и пальпация;
2. УЗИ слюнных желёз, мягких тканей лица и шеи;
3. МРТ с контрастированием при большой опухоли, рецидиве или поражении глоточного отростка;
4. ТАБ под УЗИ;
5. патолого-анатомическое исследование операционного материала.

3.2 Дифференциальная диагностика

Дифференцируют

1. доброкачественные и злокачественные опухоли между собой;
2. врождённые пороки головы и шеи, сосудистые поражения, лимфатические мальформации;
3. воспалительные процессы, актиномикоз, туберкулёз, неспецифические лимфаденопатии, аутоиммунные заболевания;
4. метастазы в околоушные, подчелюстные и верхние югулярные узлы, прежде всего при раке носоглотки, ретинобластоме, лимфоме.

3.3 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование

Что уточняют у родителей и ребёнка

1. время появления деформации лица или подчелюстной области и скорость её нарастания;
2. функцию мимической мускулатуры, наличие тризма;
3. онкологические заболевания ребёнка и родственников, вредные воздействия во время беременности, указания на врождённый характер заболевания;
4. место жительства до появления признаков заболевания.

При осмотре оценивают

1. рост, массу тела, физическое развитие;
2. железу при пальпации: подвижность узла, инфильтрацию тканей;
3. размер и подвижность лимфатических узлов шеи;
4. функцию лицевого нерва (парез, паралич), открывание рта (тризм), глотание.

При подозрении на узловое поражение железы педиатр направляет ребёнка в клинику челюстно-лицевой хирургии или детский онкологический центр.

3.4 Лабораторные исследования

При госпитализации

1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
2. биохимический анализ крови;
3. коагулограмма;
4. общий анализ мочи;
5. группа крови, резус-фактор и фенотип по антигенам эритроцитов.

3.5 УЗИ и тонкоигольная аспирационная биопсия

Всем пациентам строго рекомендуется УЗИ слюнных желёз и лимфатических узлов шеи с тонкоигольной биопсией образования (и узлов при подозрении на их поражение) и цитологическим исследованием. ТАБ признана минимально инвазивным и эффективным методом верификации.

Заключение цитолога по Миланской системе (MSRSGC) с указанием риска злокачественности

1. недиагностический материал;
2. неопухолевый процесс;
3. атипия неуточнённой значимости;
4. подозрение на злокачественное образование;
5. злокачественное образование, по возможности со степенью (low grade, high grade).

Толстоигольная (core) биопсия

1. опухоли малых слюнных желёз;
2. недиагностическая ТАБ образования околоушной железы.

У ранее оперированных больных с гистологически подтверждённым диагнозом ТАБ можно не проводить.

Открытая биопсия

1. недиагностическая ТАБ и (или) core-биопсия;
2. подозрение на неэпителиальную злокачественную опухоль: резкий рост, вовлечение соседних тканей, очаг вне железы, метастазы;
3. необходимость материала для молекулярно-генетического исследования при неоперабельной опухоли.

При обширном поражении обеих долей околоушной железы и подозрении на вовлечение лицевого нерва открытая биопсия показана после двукратного отрицательного цитологического исследования.

3.6 МРТ, КТ и другие исследования

МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием выполняется при подозрении на злокачественную опухоль; строго рекомендуется при подозрении на поражение основания черепа, периневральном росте, интракраниальном распространении, рецидиве или продолженном росте.

КТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием — при подозрении на поражение верхней или нижней челюсти, основания черепа; КТ органов грудной клетки — всем пациентам со злокачественными опухолями.

1. **остеосцинтиграфия** — при злокачественной опухоли и подозрении на метастазы в кости
2. **ПЭТ всего тела** — только на поздних стадиях; ПЭТ/КТ с ФДГ на начальных стадиях не показана
3. **УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства** — при опухолях с высоким потенциалом злокачественности (аденокарцинома)

3.7 Патолого-анатомическое заключение

Параметры заключения

1. размеры и глубина инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. оценка краёв резекции;
4. лимфоваскулярная и периневральная инвазия, pT, pN — только при злокачественной опухоли.

Цитогенетическое исследование проводится при метастатической и неоперабельной опухоли, секреторной карциноме и в сложных диагностических случаях для поиска молекулярных мишеней.

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Операция является основным методом радикального лечения злокачественных эпителиальных опухолей; её выполняют в специализированном онкологическом центре. Энуклеация опухоли приводит к продолженному росту и методом лечения не считается.

Доброкачественные опухоли удаляют хирургически в объёме частичной резекции, паротидэктомии или субтотальной резекции с выделением и сохранением лицевого нерва; операцию выполняют в специализированном центре онколог, челюстно-лицевой или пластический хирург.

Нейрофизиологический мониторинг лицевого нерва строго показан

1. при опухолях T3–T4;
2. при рецидиве и реоперации;
3. при расширенных резекциях с костями основания черепа;
4. при планировании одномоментной реконструкции лицевого нерва.

Лечение по стадиям

Стадия	Лечение злокачественной опухоли
T1–T2 N0	удаление образования с сохранением ветвей лицевого нерва под мониторингом; при поражённых узлах внутри железы — лимфаденэктомия (IA, IIA, IIB, III); при опухоли высокого потенциала злокачественности — профилактическая лимфаденэктомия на стороне поражения
T1–T2 N+ M0	полное удаление образования с сохранением лицевого нерва под мониторингом; при поражённых узлах внутри железы — лимфаденэктомия (IA, IIA, IIB, III)

Стадия	Лечение злокачественной опухоли
T3–T4a N0 M0	полное удаление с обязательным мониторингом и шейной лимфаденэктомией (IA, IIA, IIB, III, IV); при неблагоприятных гистологических признаках рассматривают конкурентную ХЛТ
T3–T4a N+ M0	полное удаление с мониторингом и расширенной шейной лимфаденэктомией; затем послеоперационная ЛТ
T4b	при невозможности радикальной операции — цитогенетическое исследование для таргетной терапии, ДЛТ или их комбинации по решению федерального консилиума
Локорегионарный рецидив	радикальная паротидэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом под мониторингом; при неоперабельности — таргетная терапия или конкурентная ХЛТ по решению консилиума федерального центра
Нерадикальная первичная операция	консилиум федерального центра решает вопрос о повторной ревизионной операции (second-look) или ЛТ

При опухоли высокого потенциала злокачественности, положительных краях или периневральной инвазии рассматривают послеоперационную ДЛТ. Профилактическая лимфодиссекция при низком и промежуточном потенциале злокачественности не рекомендуется, кроме случаев поражённых узлов внутри железы.

Достаточный край резекции

1. низкий и промежуточный потенциал злокачественности: **2 мм и более**;
2. высокий потенциал (аденокистозный рак): **5 мм и более**.

Подозрительные лимфатические узлы биопсируют одномоментно; при пересечении ветвей лицевого нерва выполняют одномоментную пластику — сшивание или аутотрансплантат большого ушного либо икроножного нерва.

4.2 Лучевая терапия

Показания к лучевой терапии

1. низкодифференцированная опухоль;
2. прорастание в основание черепа, мягкие ткани лица, экстрагландулярное распространение;
3. метастазы на шее, инвазия в сосуды или узлы;
4. опухолевые клетки по краю резекции, разрыв опухоли во время операции, большой неудалимый остаток;
5. периневральная инвазия и другие признаки агрессивной опухоли;
6. неоперабельность.

Принципы ЛТ у детей те же, что у взрослых; при топометрии и облучении детей младше 5 лет может потребоваться общая анестезия.

Дозы

1. самостоятельная ЛТ, зона высокого риска (опухоль и поражённые узлы): 66 Гр по 2 Гр;
2. зоны промежуточного и низкого риска: 44–50 Гр по 2 Гр;
3. послеоперационная ЛТ: начало **менее чем через 6 недель** после резекции; положительные края — от 66 Гр, зоны субклинического распространения — от 44–50 Гр.

Лекарственная (молекулярно-направленная) терапия по решению федерального консилиума после молекулярно-генетического исследования

1. секреторная карцинома;
2. неоперабельная опухоль;
3. отдалённые метастазы, когда возможности хирургии и ЛТ исчерпаны.

4.3 Медицинская реабилитация

На всём протяжении лечения оказывают социально-педагогическую помощь ребёнку и социально-психологическую поддержку семье. При парезе ветвей лицевого нерва проводят гимнастику и стимулирующую терапию мимических мышц под контролем логопеда, специалиста по лечебной физкультуре и невролога.

Лечение пареза и паралича мимической мускулатуры по длительности

1. **пересечение ветвей при паротидэктомии** — одномоментная пластика нерва: сшивание, аутотрансплантаты большого ушного или икроножного нерва
2. **паралич до 2 лет** — нейропластика жевательной ветвью тройничного нерва, нисходящей ветвью подъязычного нерва, кросспластика
3. **паралич более 2 лет без нейромышечной активности на ЭМГ** — транспозиция височной мышцы, васкуляризированные мышечные трансплантаты, статическая коррекция, ботулинотерапия

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и диспансерное наблюдение

Группы риска

1. дети, проживающие в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью;
2. дети после лучевой терапии на область головы и шеи;
3. дети после терапии радиоактивным йодом по поводу рака щитовидной железы;
4. дети после полихимиотерапии.

Контрольные обследования

1. первый год: **каждые 3 месяца**;
2. до 5 лет: **не реже 1 раза в полгода**;
3. далее: **не реже 1 раза в год**, при злокачественной опухоли — пожизненно.

Объём обследования

1. клиническое обследование;
2. УЗИ желёз и регионарных лимфатических узлов;
3. УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства;
4. МРТ мягких тканей головы с контрастированием;
5. при злокачественной опухоли — КТ лёгких и трёхфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей **не реже 1 раза в год**;
6. при парезе лицевого нерва — ЭМГ мимической мускулатуры с двух сторон **через 3, 6 месяцев и 1 год**.

Наблюдение при злокачественной опухоли ведёт детский онколог, при доброкачественной — челюстно-лицевой или детский хирург **до 18 лет**; при парезе лицевого нерва — также невролог, офтальмолог, врач лечебной физкультуры, клинический психолог. После 18 лет пациента переводят во взрослую сеть.

Режим

1. в период лечения вакцинация не проводится, кроме вакцинации против гепатита В;
2. физические нагрузки исключаются на период лечения и **на 1 месяц** после операции;
3. при злокачественной опухоли **в течение 5 лет** не рекомендуются инсоляция и электромиостимуляция околоушно-жевательной области;
4. при сохраняющемся поражении лицевого нерва, нарушениях глотания и жевания возможен перевод на домашнее обучение.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. кровотечение с угрозой жизни;
2. обтурация верхних дыхательных путей с показаниями к трахеостомии;
3. острая потеря сознания, кома;
4. синдром сдавления верхней полой вены;
5. остро возникшее поражение лицевого нерва на стороне опухоли.

Плановая госпитализация

1. уточняющая диагностика;
2. этапы хирургического, лучевого, лекарственного лечения;
3. симптоматическая терапия;
4. хирургическая реабилитация и ботулинотерапия при поражении лицевого нерва.

Специализированная помощь начинается **не позднее 14 календарных дней** с даты патолого-анатомической верификации или установления предварительного диагноза злокачественной опухоли.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Опухоли слюнных желёз у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 27.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	75_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сцинтиграфия костей скелета: во вводной части раздела 2 — всем при первичной диагностике, в разделе 2.4 — только при подозрении на метастатическое поражение костей.
- При парезе лицевого нерва раздел 4 рекомендует стимулирующую терапию мимических мышц, а раздел 7 не рекомендует электромиостимуляцию околоушно-жевательной области при злокачественной опухоли в течение 5 лет.